



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : رحاب رافت احمد حسين
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : روض الفرج
رقم البطاقة : 28006200101981 رقم التليفون : 01003350812
العنوان : ---
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-06-1980 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رجاى رافت اءمء ءسب National ID: 28006200101981	
---	---

ءقرفر طبى

السبء
ءءىة طبىة وبعء

بشآن ءقرفر طبى للمربض	إبماء للطلب المقءم من
رقم طبى:	بقسم:

نءشرف بان نوضء فىما ىلى ءقرفرا عن ءالءه

ءارىء وساعة ءءروج : PM 01:17 05-07-2026	ءارىء وساعة الءءول : -- --:-- yyyy-mm-dd
--	---

وبعء الكشف والفءوءصاء والمءابعة وءء اءة

المربضة ءعانى من ورم ءبر ءمبء بالءى و ءءءا ءلى Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

ءارىء : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
الطبب المعالء : ءشيماء لاشبب	



٢٠٢٠/٠٦ ٢٨٠٠٦٢٠٠١٠١٩٨١
حاصله على بكالوريوس علوم



أنثى مملعة
رياض ربيع راجع عوض
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٦/١٠



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



رحاب

راففت احمد حسين

مساكن جزيرة بدران - بلوك ١١ مدخل ١
روض الفرج - القاهرة

٢٨٠٠٦٢٠٠١٠١٩٨١

٢٨٠٠٦٢٠٠١٠١٩٨١

IK3667530

١٥٣٨٥
تاموكسفين
تدخين



Ministry of Health and Population
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة والسكان
المملكة العربية السعودية



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : **رانيا بنت احمد حسن**

Sex:

3- Medical number:

Female

03206052

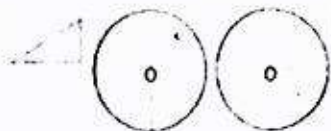
Old Med :

Genet

1507-2024

2-ID number:

Patient Age : 45 Y



Family history

Family history
+ve

Phone

Phone

01003350812

BME

BME

REASON OF MDT

REASON OF MDT
1- Breast cancer

Marital status

Marital status
+ve

KRS Score

KRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

25/12/2024 C

Comorbidity

Comorbidity
+ve

Menopausal
status

Menopausal status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Rt breast UOQ malignant looking lesion BIRADS 4c
bilateral fibroadenosis
RT UOQ multiple masses showing heterogenous mass enhancement
9 x 4.1 x 4.5 being 0.4 from nipple and 1 cm from skin

Mets Workup :

pulmonary : free
liver: free

BX
IDC

ER
3/8

PR
0/8

Her 2 Neu
3

SISH

Ki67

T
2

N
0

M
0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

rt simple mastectomy+SLNB: no residual tumor
free deep margin , skin , LN 0/4
complete pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

In view of pCR , PT2 N 0 , low ER 3/8 , Pt for :

- 1- Continue Herceptin perjeta for total of 1 year.
- 2- Hormonal treatment Tamoxifen for 5 years.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Name: رحاب رافت احمد حسين		
MR. : 5264		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient's tumor expresses estrogen receptor (ER) positivity at 3/8, progesterone receptor (PR) negativity at 0/8, and HER2 positivity scored as +3. The pathology report indicates a stage sm 11/2025, and the patient is currently free for chemotherapy. The treatment plan includes tamoxifen 20 mg daily and calcium supplementation at a dose of 1 tablet daily for 90 days, designated as ONE ALPHA. The patient continues to have ER 3/8, PR 0/8, and HER2 +3 status. Tamoxifen therapy is prescribed for a duration of three months, accompanied by supportive care for an additional three months. The next clinical follow-up is scheduled for 28 September 2026.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد	
يعتمد ,		

Patient Name : الأمل / رباب رائف أحمد حسن	Request No. : 13009545
Patient No. : 28006200101981	Request Date : 24/11/2024
Path No. : 4575/24	Verification Date : 05/12/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - أورام دار السلام
Age : 44 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Right simple mastectomy and sentinel lymph nodes biopsy.

Gross Examination:

- * Procedure: Right simple mastectomy specimen measured 19x18x2.5 cm with covering skin ellipse measured 12x17 cm.
- * Localization: UOQ
- * Tumor extent: A rubbery greyish white tumor bed site.
- * Size: 10x9x2 cm
- * Skin involvement: Unremarkable grossly
- * Distance from margins: 0.3 cm away from deep margin and 1.7 cm away from the skin located centrally.
- * Sentinel Lymph nodes number and size: Fibrofatty tissue piece measured 4x3 cm, entangling 4 LNs up to 1.7x1 cm.
- * Frozen section: One suspicious lymph node (0/4).

Microscopic Examination:

- * Histological type: No residual tumor tissue (totally burnt out)
- * Ductal carcinoma in situ: No
- * Skin involvement: Free nipple
- * Lymph node involvement: Free sentinel lymph nodes (0/4).
- * Resection Margins: Free deep margin
- * Histologic response to therapy: Complete pathological response.

Diagnosis:

Right breast cancer (Post-NACT), Simple mastectomy and sentinel lymph nodes biopsy:
No residual tumor tissue (totally burnt out)
- Free deep margin

Verified by :

Dr.Toka Medhat

Printing Date : 11/12/2024 10:03:49

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - أودنوش النيل - قصر القديسة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mir El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / رانيا رالف احمد حسن	Request No.	: 13009545
Patient No.	: 28006200101981	Request Date	: 24/11/2024
Path No.	: 4575/24	Verification Date	: 05/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - فئة الدولة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

- Free skin
- Free sentinel lymph nodes (0/4).
- Complete pathological response to therapy
- Stage: ypT0, ypN0

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Menna Nabil

Verified by :
Dr. Toka Medhat

Printing Date : 11/12/2024 10:03:49

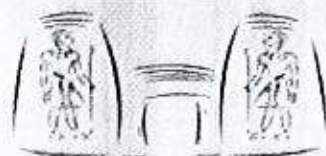
Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed yousa



شركة رام (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mit El Qadema - Cairo, Egypt

الكرنك للأشعة والتحاليل Karnak Scan & Lab



Echocardiography Report

Name: Rehab Raafat Ahmed

Referring Doctor:

Date: 12-07-2025

2D & M-mode Echocardiography

Left Ventricle:

LVEDD:	57 mm	(37-56 mm)
LVESD:	37 mm	(24-37mm)
EF:	63%	(53- 77%)
FS%:	35%	(24-46%)
IVST:	7 mm	(7-11mm)
PWT:	7 mm	(7-11 mm)
Aortic root:	30 mm	
LA:	34 mm	

Conclusion:

- Normal LV internal dimensions with normal systolic function with an EF of 63% by 2D eyeballing and same range by M-Mode.
- Normal LV diastolic function.
- Normal LV wall thickness.
- No RSWMA.
- Normal LA and aortic root dimensions.
- Degenerative MV leaflets with mild MR.
- Sclerotic AV leaflets with no significant gradient across and no AR.
- Normal RV dimensions with normal systolic function.
- Normal TV morphology with mild TR, normal estimated RVSP.
- No intra-cardiac masses or thrombi detected by TTE.
- No pericardial effusion.

Dr. Ahmed Adel,
MSc Cardiology



PATIENT NAME: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN

GENDER: Female

DATE : 11-Jul-2024 11:55 AM

PATIENT ID: 20224007679

AGE: 44 y

ORDER: 2933949

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Prof. Huda Fathy, Nuclear Medicine Consultant

11-Jul-2024 11:26 AM

PATIENT: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN, 20224007679, Female, 44 y
Report version 2, 11-Jul-2024 11:26 AM

Page 1 of 1



www.Baheya.org



16602

مركز طبعة الهرم
4 شارع غزالة نول شارع الهرم بجوار داري الجيزة

مستشفى دينا الشرق
1 إلى الأول - الشيخ زايد أمام كلية الهندسة

PATIENT NAME: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN
GENDER: Female
DATE : 26-May-2024 09:34 AM

PATIENT ID: 20224007679
AGE: 43 y
ORDER: 2861925

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

INDICATION:

- right pathologically proved malignant mass

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO views

REPORT:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed left asymmetrical faint heterogeneous back ground parenchymal enhancement.
- Right UOQ multiple masses showing moderate heterogenous mass enhancement measured collectively 9x4.1x4.5 cm, being 0.4 cm from the nipple, and 1 cm from the overlying skin
- No left pathological breast mass or non mass enhancement.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.

OPINION:

- Right UOQ multifocal pathologically proved pathologically enhancing lesions (BIRADS 6).
- No left breast pathological mass or non mass enhancement (BIRADS 2)

Reported By,

Dr. Yasmin Nada, MSc

26-May-2024 10:11 AM



PATIENT NAME: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN

GENDER: Female

DATE : 25-Apr-2024 10:22 AM

PATIENT ID: 20224007679

AGE: 43 y

ORDER: Z73348,Z73349

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Right UOQ lesion (pathologically proven IDC grade II-III)

TECHNIQUE:

- CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- The breasts are heterogenoussly dense, which may obscure small masses (ACR C).
- Right UOQ posterior third isodense irregular shaped lesion, this is associated with fine pleomorphic calcifications showing linear distribution seen extending form the marging of the lesion (0.7 cm from the lesion) over a distance of 4.5 cm, it is seen about 2.3 cm from the nipple (measurements on RT CC)
- This was confirmed by Complementary Ultrasound which showed right 2 o'clock (zone C) irregular shaped hypoechoic lesion measures 1.9x1.3 cm, it is seen about 0.3 cm from the skin .
- No left breast solid or cystic lesions
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complexes.
- Nonspecific axillary lymph nodes at both sides.
- Free supra and infra claviclar regions at both sides.

OPINION:

- Right UOQ pahtologically proven malignant lesion with associated fine pleomorphic microcalcifications showing linear distribution as described (BIRADS 6)
- Normal left breast (BIRADS1).

PATIENT: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN, 20224007679, Female, 43 y

Report version: 1, 25-Apr-2024 11:05 AM

Page 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الهرم
و شارع عبودة اول شارع الهرم بجوار داري - الجيزة
مستشفى بهية الشيخ زايد
ع. ابي الأول - الشيخ زايد امام كلية الهندسة

PATIENT NAME: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN

GENDER: Female

DATE : 27-Apr-2024 09:35 AM

PATIENT ID: 20224007679

AGE: 43 y

ORDER: 2818330,2818331

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH TRIPHASIC CT STUDY OF THE LIVER

**Reported case of breast cancer.

1-CHEST

- Right breast upper outer quadrant soft tissue lesion, measuring 1.4 x 1.8 cm along its maximum axial dimensions.
- Right breast outer aspect heterogenous parenchymal enhancement.
- No pathologically enlarged axillary lymph nodes.
- Few right upper lung lobe, tiny pulmonary nodules, the largest measuring 0.2 cm in diameter, likely non specific.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- Bilateral fine apical subpleural reticulations.
- Few small subcentimetric right paratracheal and right hilar lymph nodes, likely nonspecific.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is mildly enlarged with homogenous CT texture. No focal lesions or intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys 9 aprt from right renal gravel, right adrenal, aorta (apart from small atheromatous calcification) and I.V.C.
- Bulky left adrenal gland.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular

PATIENT: REHAB RAAFAT AHMED HUSEN-20224007679-Female-43 y

Report version: 3-28-Apr-2024 01:27 P.M.

Page: 1 of 2



www.Baheya.org



16602

مركز بهية الهرم
و شارع علي قنديل شارع الهرم بجوار داري الجيزة

مستشفى بهية الشيخ زايد
في الحي الاول - الشيخ زايد امام كلية الهندسة

outpouching.

- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
 - Minimal pelvic ascites, likely physiological.
 - IUD is noted in situ with relatively bulky cervix showing internal fluid density.
 - Small fat containing umbilical hernia.
 - **The revised bone window revealed:**
1. No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.

Opinion:

- Right breast upper outer quadrant neoplastic lesion.
- Mild hepatomegaly.
- No CT evidence of pulmonary, osseous or hepatic deposits.

Reported By,

Dr. Nema Aboalmagd, MSc

Dr. Mennatallah Mohamed, MD

28-Apr-2024 01:27 PM

